文章编号:1005-0957(2026)02-0142-08　　· 临床研究 ·

针刺对卒中后运动性失语患者言语功能和血液学指标的影响

周冰原[1],朱才丰[2,3,4],杨坤[2],吴萌萌[2],李静[2],高大红[2],陈希阳[1],王雪伟[1],杨高尚[1],程乐[1],姜世豪[1],吴安琪[1]
(1.安徽中医药大学,合肥 230038;2.安徽中医药大学第二附属医院,合肥 230061;3.安徽省中医药科学院针灸临床研究所,合肥 236231;4.经脉脏腑相关安徽省重点实验室,合肥 230038)

【摘要】　目的　观察综合针刺治疗卒中后运动性失语(post-stroke motor aphasia, PSMA)的临床疗效及对血液学指标的影响。**方法**　将 74 例 PSMA 患者以简单随机数字表法随机分为观察组和对照组,每组 37 例。两组均予以西医基础治疗,对照组另予普通针刺,观察组另予综合针刺。比较两组临床疗效和不良反应发生情况,观察两组治疗前后汉语失语症检查法(aphasia battery of Chinese, ABC)评分、波士顿诊断性失语症检查(Boston diagnostic aphasia examination, BDAE)分级、美国国立卫生研究院卒中量表(National Institutes of Health stroke scale, NIHSS)评分、简易智力状况检查量表(mini-mental state examination, MMSE)评分、血清降钙素基因相关肽(calcitonin gene-related peptide, CGRP)水平、血管内皮素(endothelin, ET)水平、神经烯醇化酶(neuron-specific enolase, NSE)水平、红细胞聚集指数、全血黏度及血沉方程 K 指数的变化。**结果**　观察组总有效率高于对照组($P<0.05$)。治疗后,两组 ABC 中听理解、自发言语和复述及命名的评分均升高($P<0.05$),且观察组高于对照组($P<0.05$)。治疗后,观察组 BDAE 分级较治疗前明显改善($P<0.05$),且优于对照组($P<0.05$)。治疗后,两组 NIHSS 评分均降低($P<0.05$),且观察组低于对照组($P<0.05$);两组 MMSE 评分均升高($P<0.05$),且观察组高于对照组($P<0.05$)。治疗后,两组血清 CGRP 水平均升高($P<0.05$),且观察组高于对照组($P<0.05$);ET 及 NSE 水平均降低($P<0.05$),且观察组低于对照组($P<0.05$)。治疗后,两组全血黏度、红细胞聚集指数及血沉方程 K 指数均降低($P<0.05$),且观察组均低于对照组($P<0.05$)。两组未有不良反应发生。**结论**　在西医基础治疗基础上,综合针刺可进一步改善 PSMA 患者语言功能、认知功能、血清学及血液流变学指标,改善失语症状,疗效优于普通针刺。

【关键词】　针刺疗法;头针;三棱针疗法;舌针;失语症;中风后遗症
【中图分类号】　R246.6　　**【文献标志码】**　A
DOI:10.13460/j.issn.1005-0957.2025.14.0012

Effect of acupuncture on speech function and hematological indicators in patients with post-stroke motor aphasia

ZHOU Bingyuan[1], *ZHU Caifeng*[2,3,4], *YANG Kun*[2], *WU Mengmeng*[2], *LI Jing*[2], *GAO Dahong*[2], *CHEN Xiyang*[1], *WANG Xuewei*[1], *YANG Gaoshang*[1], *CHENG Le*[1], *JIANG Shihao*[1], *WU Anqi*[1].　1.*Anhui University of Chinese Medicine*, *Hefei* 230038, *China*; 2.*The Second Affiliated Hospital of Anhui University of Chinese Medicine*, *Hefei* 230061, *China*; 3.*Clinical Research Institute of Acupuncture and Moxibustion*, *Anhui Academy of Traditional Chinese Medicine Sciences, Hefei* 236231, *China*; 4.*Anhui Province Key Laboratory of Meridian Viscera Correlationship*, *Hefei* 230038, *China*

[Abstract]　Objective　To observe the clinical efficacy of comprehensive acupuncture treatment for

基金项目:安徽省新时代育人质量工程项目(2024xscx104);安徽省华佗中医药研究院科技重大专项“揭榜挂帅”项目(BZKZ2402);安徽省中医药传承创新科研项目(2024CCCX004);安徽中医药大学探索性科研项目(AHUCM2024TS124);安徽省自然科学基金项目(2208085MH273);国家级重点专科项目-老年病优势专科建设[国中医药医政函(2024)90号];省级重点专科项目-老年病优势专科建设[皖卫函(2021)273 号];青年江淮名医[皖卫函(2022)392 号]

作者简介:周冰原(1994—),男,2023 级博士生,Email:1327182084@qq.com
通信作者:朱才丰(1981—),男,主任医师,博士生导师,Email:727687720@qq.com

中国知网　https://www.cnki.net

post-stroke motor aphasia (PSMA) and its impact on hematological indicators. **Method** Seventy-four patients with PSMA were randomized into an observation group and a control group using a simple random number table method, with 37 cases in each group. Both groups received basic Western medicine treatment. In addition, the control group was treated with ordinary acupuncture, and the observation group received comprehensive acupuncture treatment. The clinical effectiveness and adverse reactions were compared between the two groups. Before and after treatment, changes in the aphasia battery of Chinese (ABC) score, Boston diagnostic aphasia examination (BDAE) grading, National Institutes of Health stroke scale (NIHSS) score, mini-mental state examination (MMSE) score, serum calcitonin gene-related peptide (CGRP) level, endothelin (ET) level, neuron-specific enolase (NSE) level, erythrocyte aggregation index, whole blood viscosity, and erythrocyte sedimentation rate equation K value were observed. **Result** The total effective rate was higher in the observation group than in the control group ($P<0.05$). After treatment, the ABC subscale scores of auditory comprehension, spontaneous speech, repetition, and naming increased significantly in both groups ($P<0.05$) and were higher in the observation group than in the control group ($P<0.05$). After treatment, the observation group demonstrated notable improvement in BDAE grading ($P<0.05$) and was superior to the control group ($P<0.05$). After intervention, the NIHSS score decreased in both groups ($P<0.05$) and was lower in the observation group than in the control group ($P<0.05$); the MMSE score increased in the two groups ($P<0.05$) and was higher in the observation group than in the control group ($P<0.05$). After treatment, both groups showed an increase in the serum CGRP level ($P<0.05$), and the observation group was higher than the control group ($P<0.05$); the levels of ET and NSE dropped in both groups ($P<0.05$) and were lower in the observation group than in the control group ($P<0.05$). After treatment, both groups demonstrated decreases in the whole blood viscosity, erythrocyte aggregation index, and erythrocyte sedimentation rate equation K value ($P<0.05$), and the observation group was lower than the control group ($P<0.05$). Neither group experienced adverse reactions. **Conclusion** Based on the basic Western medicine treatment, comprehensive acupuncture treatment can further improve PSMA patients' speech function, cognitive function, serological and hemorheological indicators, and aphasia symptoms, producing more significant effectiveness than ordinary acupuncture.

[Key words] Acupuncture therapy; Scalp acupuncture; Three-edged needle therapy; Tongue acupuncture; Aphasia; Post-stroke syndrome

卒中是一种高死亡率和高残疾率的破坏性神经系统疾病,是导致长期残疾的第三大原因[1]。卒中患者中约有 21%～38%存在失语症,最常见于左侧皮质卒中患者[2]。卒中后运动性失语(post-stroke motor aphasia, PSMA)是指由于卒中造成大脑左侧额下回皮质(Broca 区)受损导致的语言认知功能障碍[3-4]。PSMA 主要表现为口语表达障碍,甚至完全丧失言语,并随着时间的推移增加抑郁症和其他心理障碍的风险[5]。临床上言语和语言治疗(speech and language therapies, SPEM)是目前的标准治疗,但其提供的效果有限[6]。在大量失语症患者中,语言康复的需求与目前高效且可获得的治疗方法之间的差距越来越大,因此寻求一种有效、便捷的疗法迫在眉睫。针灸是一种中医特色传统疗法,常与 SPEM 相结合治疗 PSMA,并显示出显著的疗效。补肾通督针刺法是国家级名老中医、梅花针灸流派第七代传承人蔡圣朝教授总结四十余年临床经验提出的 PSMA 治疗大法。本研究目的在于探究补肾通督针刺疗法对 PSMA 患者的治疗效果,同时探讨其对相关血液学指标的作用,以期为临床实践提供参考。

1 临床资料

1.1 一般资料

以安徽中医药大学第二附属医院老年病三科 2023 年 1 月至 2024 年 12 月收治的处于卒中恢复期及后遗症期 PSMA 住院患者作为研究对象。依据《医学统计方法学》[7]中完全随机设计两样本率比较公式进行样本量估算,基于预试验数据设定观察组有效率 90%和对照组 70%,同时考虑 15%脱落率,最终确定每组纳

中国知网 https://www.cnki.net

入 37 例,总样本 74 例。采用随机数字表法将纳入的 74 例患者平均随机分配至观察组和对照组,每组 37 例。观察组中男 22 例,女 15 例;年龄 42～76 岁,平均年龄(63±8)岁;病程 3.7～8.4 个月,平均病程(6.33±1.25)个月;缺血型卒中30例,出血型卒中7例;合并高血压 30 例,糖尿病 8 例。对照组中男 17 例,女 20 例;年龄 43～74 岁,平均年龄(62±9)岁;病程 3.3～8.1 个月,平均病程(5.95±1.39)个月;缺血型卒中31例,出血型卒中6例;高血压28例,糖尿病9例。统计分析结果表明,两组一般资料比较,差异均无统计学意义(P>0.05),具有可比性。本研究方案经安徽中医药大学第二附属医院伦理委员会审批通过(批件号 2022-SXXM09)。

1.2　诊断标准

1.2.1　西医诊断标准

卒中的临床诊断须满足《中国各类主要脑血管病诊断要点 2019》[8]中的相关标准,同时经颅脑磁共振成像或计算机断层扫描检查确认。失语的诊断参照《汉语标准失语症检查法的编制与常模》[9]中失语症的标准,并通过《论汉语失语检查法标准化》[10]评估。运动性失语以口语表达障碍最突出,以能够理解对话和文字,对名字有反应,但讲话费力不流畅,发音障碍,复述、命名、阅读、书写功能均有不同程度的受损者确诊运动性失语。

1.2.2　中医诊断标准

中风的临床诊断参照《中医内科病证诊断疗效标准(ZY/T001.1-94)》[11],其核心症状包括偏侧肢体瘫痪、言语不清或困难、口角歪斜、半身麻木,病情严重者可出现意识模糊、神志不清、昏睡乃至深度昏迷。中风后失语定义为中风并伴有言语謇涩或失语者[12]。中风后失语是中风病引发的局部症状,根据中医学“治病求本”的核心原则,将中风后失语证候分类标准参照《中医内科学》[13]的中风章节,以患者处于中风恢复期及后遗症期为标准,分为痰瘀阻络证、气虚血瘀证和肝肾亏虚证。

1.3　纳入标准

符合上述各项诊断标准;处于卒中恢复期和后遗症期,病情稳定,卒中次数<3 次;构音障碍非因发音器官受损,排除他病;经头颅CT或MRI检查后被证实为脑血管意外;年龄 40～80 岁,为右利手,母语汉语;能够配合治疗,患者及家属签署知情同意书。

1.4　排除标准

有严重心脑血管合并症、癫痫、精神病者;存在重度耳聋、重度认知障碍、意识障碍而无法配合治疗者;依从性差者;严重肝肾功能障碍、恶性肿瘤或其他重大全身疾病者;有晕针史或严重针刺恐惧者,或针刺部位存在感染、溃疡者;有抑郁症者(诊断明确);正在接受可能影响本研究核心观测指标的其他治疗者。

1.5　剔除和脱落标准

误诊者;病情加重不能继续受试者;未按规定试验方案进行治疗者;自行申请退出者;缺乏全部检测记录者;依从性不佳且拒绝合作者;其他原因造成随访中断者。

2　治疗方法

两组均予以西医基础治疗。参照《中国脑血管病防治指南》[14]制定,包括抗凝、抗血小板聚集、保护脑神经、改善脑代谢、控制危险因素的治疗,如控制血压、血糖、血脂,抗感染、防治并发症等。

针刺治疗由拥有 5 年及以上临床经验的针灸专科医师操作。

2.1　对照组

予普通针刺治疗。常规取穴,以局部取穴为主,取扶突(双)、天鼎(双)、阿是穴(颈项部)、列缺(双)及照海穴(双)。治法为疏经通络,利喉开音。针刺部位以碘伏棉签或乙醇棉签常规消毒,进行常规针刺。针列缺、照海行针时,可配合做吞咽动作。每日 1 次,每周治疗 6 次。每周休息 1 d 再继续治疗,共治疗 4 周。

2.2　观察组

予综合针刺治疗。

2.2.1　体针

主穴选取肾俞(双)、太溪(双)、涌泉(双)、中脘、关元、百会、神庭、风府和风池穴(双),结合辨证加减,气虚血瘀者配气海、膈俞和血海穴,痰瘀阻络者配丰隆和血海穴,肝肾亏虚者配太冲和三阴交穴。使用 0.30 mm×40 mm 一次性毫针,四肢穴位垂直 90° 进针,刺入深度 0.5～0.8 寸,依据患者体型(胖瘦)而确定,腧穴局部产生酸、麻、胀、痛或肌肉抽动为得气感;风府穴朝向下颌方向进针,可进针 0.5～1 寸;风池穴朝向鼻尖方向斜刺 0.8～1.2 寸;百会和神庭穴进针时,针体与头皮成 15° 夹角刺入帽状腱膜下层,针刺深度达 1.0 寸,操作过程中不行提插手法,而以 100 次/min

中国知网　https://www.cnki.net

的频率实施快速捻转,持续 2～3 min。留针 30 min。

2.2.2 头针

运动性失语选择言语一区作为主穴。患者取端坐位,采用 0.30 mm×40 mm 一次性毫针进针时,针体与头皮成 15° 夹角刺入帽状腱膜下层,针刺深度达 1.0 寸;操作过程中不行提插手法,而以 100 次/min 的频率实施快速捻转,持续 2～3 min。随后,在百会穴及患侧言语一区连接 KWD-808I 型脉冲针灸治疗仪,选用疏密波(疏波 2 Hz,密波 50 Hz,电流强度 2 mA)。毫针留置于体内 30 min。

2.2.3 舌针

选取廉泉和承浆穴,生理盐水漱口,使患者自然伸舌于口外,按前中后和左中右将舌面分为 9 区,取 0.30 mm×40 mm 一次性针灸针在 9 区内逐一进行点刺,以出血为佳,不留针。

2.2.4 三棱针

采用 1.5 mm×63 mm 三棱针,经严格无菌处理后,直接点刺风府穴,深度 0.5～1.0 cm,放血 1～2 滴。

舌针为隔日 1 次(每周 3 次),头针配合体针、三棱针则为每日 1 次(每周 6 次)。每周治疗 6 d 后休息 1 d,总疗程为 4 周。

3 治疗效果

3.1 观察指标

3.1.1 主要指标

汉语失语症检查法(aphasia battery of Chinese, ABC),主要用于评定患者言语功能,选取听理解、复述、自发言语与命名 4 项评分,评定两组患者治疗前后语言功能评分及其差值。评分越高提示患者言语功能越好。

3.1.2 次要指标

3.1.2.1 波士顿诊断性失语症检查(Boston diagnostic aphasia examination, BDAE)[15]

将受试者语言能力分为 0～5 级。

0 级:无有意义的言语,无听觉理解能力。

1 级:言语表达不连续,可理解或说出少量词汇。

2 级:在帮助下可进行简单的交流,可表达或理解简单短语。

3 级:在少量帮助下几乎可谈论日常所有话题。

4 级:可理解复杂谈话,且可表达自己意愿,可被察觉到稍有理解障碍。

5 级:极为轻微的表达或理解障碍,仅自己可主观感觉到,听者不一定能明显察觉到。

3.1.2.2 美国国立卫生研究院卒中量表(National Institutes of Health stroke scale, NIHSS)评分[16]

主要用于评估神经功能的缺损程度,共包括 13 个项目,包括上肢运动、下肢运动、共济运动、感觉、意识、面瘫、忽视、构音障碍、语言、提问、执行指令、眼球运动、视野。

3.1.2.3 简易智力状况检查量表(mini-mental state examination, MMSE)[17]

该量表涵盖语言能力、记忆力、定向力、注意力和计算力共 4 项内容,总分为 30 分。

3.1.2.4 血液学指标检测

分别于治疗前、治疗后收集血液学指标进行评估。血清学指标,清晨采集患者 5 mL 空腹静脉血,常规离心取血清,酶联免疫吸附法(enzyme-linked immunosorbent assay, ELISA)检测血清降钙素基因相关肽(calcitonin gene-related peptide, CGRP)、血管内皮素(endothelin, ET)、神经烯醇化酶(neuron-specific enolase, NSE)水平。血液流变学指标,清晨采集患者 5 mL 空腹静脉血,采用 NXE-1 型椎板式黏度计检测患者红细胞聚集指数、全血黏度与血沉方程 K 指数。

3.1.3 安全性评价

在治疗过程中,需密切观察并详细记录不良反应(如晕针、滞针、感染、过敏、皮下血肿等),及时予以处理,并分析其与研究干预的关联性。

3.2 疗效标准

依据汉语失语症检查法评分标准,即分析听理解、自发言语、复述和命名 4 个维度治疗前后的得分变化,计算其改善率。改善率＝[(治疗后得分－治疗前得分)/治疗前得分]×100%。

显效:改善率≥50%。

有效:改善率≥30%且＜50%。

进步:改善率≥10%且＜30%。

无效:改善率＜10%。

整体有效:任一维度改善率≥10%(即达到进步、有效或显效标准)。

3.3 统计学方法

本研究利用 SPSS26.0 软件处理所有数据。对于计量资料,首先应用 Shapiro-Wilk 检验判断其是否符合

中国知网 https://www.cnki.net

正态分布。满足正态性假设的数据,数据报告为均数±标准差。组内前后比较使用配对 t 检验,不同组间比较采用两样本独立 t 检验。不符合正态分布的数据,采用中位数(下四分位数,上四分位数)进行统计描述,组内比较选用 Wilcoxon 符号秩检验,组间比较则应用 Mann-Whitney U 检验。计数资料以例表示,组间差异的检验方法为卡方检验。涉及等级资料时,组间比较采用 Mann-Whitney U秩和检验。所有假设检验均以 $P<0.05$ 作为差异有统计学意义的判断标准。

3.4　治疗结果

3.4.1　两组治疗前后 ABC 各项评分比较

治疗前,两组听理解、自发言语、复述及命名评分比较差异无统计学意义($P>0.05$),具有可比性。治疗后,两组 ABC 评分中听理解、自发言语、复述及命名 4 个评分指标均升高($P<0.05$),观察组治疗后 ABC 评分中听理解、自发言语、复述及命名 4 个评分指标高于对照组($P<0.05$)。详见表 1。

表 1　两组治疗前后语言功能评分比较($\bar{x}\pm s$)　　单位:分

组别	例数	时间	听理解评分	自发言语评分	复述评分	命名评分
观察组	37	治疗前	94.22±15.02	19.46±5.76	38.89±8.06	29.03±8.75
		治疗后	123.32±15.28[1)2)]	33.68±6.37[1)2)]	69.97±10.61[1)2)]	63.46±11.12[1)2)]
对照组	37	治疗前	93.97±14.46	18.16±5.16	40.08±9.18	31.19±9.05
		治疗后	111.27±14.74[1)]	28.24±6.73[1)]	58.59±10.25[1)]	52.05±11.34[1)]

注:与同组治疗前比较 [1)]$P<0.05$;与对照组比较 [2)]$P<0.05$。

3.4.2　两组治疗前后 BDAE 分级比较

治疗前,两组 BDAE 分级情况比较,差异无统计学意义($P>0.05$),具有可比性。治疗后,两组 BDAE 分级均降低($P<0.05$),且观察组 BDAE 分级优于对照组($P<0.05$)。详见表 2。

表 2　两组治疗前后 BDAE 分级比较　　单位:例

组别	例数	时间	BDAE 分级					
			0 级	1 级	2 级	3 级	4 级	5 级
观察组	37	治疗前	2	5	14	14	2	0
		治疗后	0	2	5	8	16	6
对照组	37	治疗前	3	6	11	13	4	0
		治疗后	0	6	9	11	8	3

3.4.3　两组治疗前后 NIHSS 和 MMSE 评分比较

治疗前,两组 NIHSS、MMSE 评分比较,差异无统计学意义($P>0.05$),具有可比性。治疗后,两组 NIHSS 评分均降低($P<0.05$),MMSE 评分均升高($P<0.05$);观察组NIHSS 评分低于对照组($P<0.05$),MMSE 评分高于对照组($P<0.05$)。详见表 3。

表 3　两组治疗前后 NIHSS 和 MMSE 评分比较($\bar{x}\pm s$)　　单位:分

组别	例数	时间	NIHSS 评分	MMSE 评分
观察组	37	治疗前	10.68±3.24	14.92±3.75
		治疗后	5.49±1.89[1)2)]	22.92±1.96[1)2)]
对照组	37	治疗前	11.51±3.68	14.35±3.96
		治疗后	8.57±2.71[1)]	18.41±3.54[1)]

注:与同组治疗前比较 [1)]$P<0.05$;与对照组比较 [2)]$P<0.05$。

3.4.4　两组治疗前后血清学指标比较

治疗前,两组血清 CGRP、ET 和 NSE 水平比较差异无统计学意义($P>0.05$),具有可比性。治疗后,两组血清 CGRP 均升高($P<0.05$),血清 ET 和 NSE 水平均降低($P<0.05$);观察组血清 CGRP 水平高于对照组($P<0.05$),ET 及NSE 水平低于对照组($P<0.05$)。详见表 4。

表 4　两组治疗前后血清学指标比较($\bar{x}\pm s$)

组别	例数	时间	CGRP/(ng·L^{-1})	ET/(ng·L^{-1})	NSE/(ng·mL^{-1})
观察组	37	治疗前	91.30±10.20	106.84±12.84	5.25±1.76
		治疗后	115.57±12.87[1)2)]	89.70±15.19[1)2)]	2.93±0.59[1)2)]
对照组	37	治疗前	91.41±10.84	106.27±12.75	5.08±1.64
		治疗后	104.54±9.36[1)]	98.19±12.83[1)]	3.75±0.78[1)]

注:与同组治疗前比较 [1)]$P<0.05$;与对照组比较 [2)]$P<0.05$。

中国知网　https://www.cnki.net

3.4.5 两组治疗前后血液流变学指标比较

治疗前,两组患者的全血黏度、红细胞聚集指数及血沉方程 K 指数比较差异无统计学意义($P>0.05$),具有可比性。治疗后,两组全血黏度、红细胞聚集指数及血沉方程 K 指数均降低($P<0.05$);观察组全血黏度、红细胞聚集指数及血沉方程 K 指数低于对照组($P<0.05$)。详见表 5。

表 5 两组治疗前后血液流变学指标比较($\bar{x}\pm s$)

组别	例数	时间	全血黏度/(mPa·s^{-1})	红细胞聚集指数	血沉方程 K 指数
观察组	37	治疗前	18.99±6.12	2.13±0.64	125.49±28.16
		治疗后	14.64±5.07[1)2)]	1.32±0.46[1)2)]	92.46±15.20[1)2)]
对照组	37	治疗前	19.02±5.86	2.25±0.53	127.63±27.92
		治疗后	16.44±3.96[1)]	1.79±0.54[1)]	111.33±19.37[1)]

注:与同组治疗前比较 [1)]$P<0.05$;与对照组比较 [2)]$P<0.05$。

3.4.6 两组临床疗效比较

观察组总有效率 91.9%,高于对照组的 67.6%($P<0.05$)。详见表 6。

表 6 两组临床疗效比较 单位:例

组别	例数	显效	有效	进步	无效	总有效率(%)
观察组	37	10	13	11	3	91.9[1)]
对照组	37	4	6	15	12	67.6

注:与对照组比较 [1)]$P<0.05$。

3.5 两组不良反应发生情况

治疗期间两组均未见不良反应,如晕针、感染、血肿等。

4 讨论

在全球范围内,卒中患者每年新增超过 1 000 万例,其中卒中后失语症约占其新发病例数目的 1/3[18]。PSMA 作为卒中后失语症主要类型之一,对患者的生活质量和社交能力造成了较大的影响。PSMA 属中医学“舌喑”“瘖痱”“风懿”“风喑”“风癔”“暴瘖难言”“中风不语”“中风语涩”等范畴[19]。PSMA 的中医学发病机制主要为年老之人肾精亏虚,脑髓失充、心神失养,致痰瘀内生、蒙蔽清窍,表现为舌强语謇、表达困难等 PSMA 症状。此外,中风后脑络受损,气血逆乱,痰瘀互结,阻塞脑窍,使“神不导气”,进一步造成语言功能失司。这与西医学中语言中枢低灌注程度影响失语症严重程度的机制有相似之处[20]。针刺能够促进 PSMA 患者语言相关脑区的活动,对其恢复具有促进作用[21]。治疗应以补肾通督为纲,以“补肾活血,解语开窍”为原则。针刺治疗采用蔡圣朝教授“辨经取穴”的方针[22],从“神-脑-督脉-肾-任脉”轴出发[23]。肾俞、太溪和涌泉补肾益精以固先天之本,百会和神庭升阳醒神而调脑窍,风府和风池祛风通络以解外邪,中脘和关元健运脾胃、培补元气,廉泉和承浆直接疏通舌咽部经气;配合 PSMA 对应的言语一区头针结合电针以激活语言中枢。同时针对病机特点进行辨证配穴,气虚血瘀加气海补气、膈俞活血、血海调血,痰瘀阻络用丰隆豁痰、血海化瘀,肝肾亏虚取太冲平肝、三阴交滋肾。诸穴协同既可调整脏腑气血,又能疏通脑络、开窍启语,体现中医整体辨证与局部取穴相结合的治疗特色。

本团队在前期一项针对近 30 年失语症研究状况及趋势的可视化分析[24]中发现,气虚血瘀证、肾虚痰瘀证是 PSMA 的主要证候,头针与舌针联合治疗能够有效改善 PSMA 患者的神经功能、提高其语言沟通能力,并且针刺法及取穴种类的研究是当下 PSMA 临床治疗的趋势。本研究结果显示,采用补肾通督针刺法治疗后,语言功能评分及失语程度分级得到明显改善。此外,补肾通督针刺法能够明显改善 PSMA 患者认知功能,与语言功能存在紧密的神经生物学联系,直接影响语言流畅性,因此,补肾通督针刺法在疗效上显示出其独特的优势和特点。

本次研究发现,两组患者治疗后血清 CGRP 水平升高,ET 及 NSE 水平降低,且观察组治疗后血清 CGRP 水平高于对照组,ET 及 NSE 水平低于对照组。CGRP 是重要的血管舒张神经肽,能够强效血管舒张作用,促进组织修复和血管新生[25]。ET 是一种强内源性血管收缩因子,其水平升高预示心脑血管事件风险增加[26]。NSE 特异性分布于神经元和神经内分泌细胞,是一种糖酵解关键酶。NSE 水平降低表明神经元损伤减少,神经炎症反应减轻[27]。本次研究发现,两组治疗后全血黏度、红细胞聚集指数及血沉方程 K 指数均降低,且观察组治疗后全血黏度、红细胞聚集指数及血沉方程 K 指数低

中国知网 https://www.cnki.net

于对照组。全血黏度反映血液流动时的内摩擦阻力[28]，黏度升高会增加血流阻力，导致组织缺血缺氧，与高血压、动脉硬化、血栓形成密切相关。红细胞聚集指数及血沉方程K指数异常与炎症反应、氧化应激、纤维蛋白原升高等病理状态相关。治疗后指数下降提示红细胞分散性改善，血栓风险降低。血清学及血液流变学指标的改善能够降低血栓风险并改善组织供血，提示补肾通督针刺法在改善大脑微循环和血液流动性方面更具优势。

综上所述，采用基础治疗联合综合针刺对PSMA患者具有多重治疗效应，患者语言及认知功能障碍得到明显改善，血清及血液流变学参数呈现良性改变。然而受限于当前单中心研究的样本规模，所得结论有一定的临床局限性，未来将联合多中心开展大样本队列研究，以期获得更高等级的循证医学证据。

参考文献

[1] ZHANG T, ZHAO J, LI X, *et al*. Chinese Stroke Association guidelines for clinical management of cerebrovascular disorders: executive summary and 2019 update of clinical management of stroke rehabilitation[J]. *Stroke Vasc Neurol*, 2020(3):250-259.

[2] BERTHIER M L. Poststroke aphasia: epidemiology, pathophysiology and treatment[J]. *Drugs Aging*, 2005(2):163-182.

[3] 姜晓丽，王盛春. 针刺治疗脑卒中后运动性失语临床研究进展[J]. 国际中医中药杂志，2022(7):830-833.

[4] PANEL O. Ottawa panel evidence-based clinical practice guidelines for post-stroke rehabilitation[J]. *Top Stroke Rehabil*, 2006(2):1-269.

[5] FENG S, TANG M, HUANG G, *et al*. Comparison of the efficacy of acupuncture-related Therapies for post-stroke motor aphasia: a Bayesian network meta-analysis[J]. *Front Neurol*, 2022:992079.

[6] SHAH-BASAK P, BOUKRINA O, LI X R, *et al*. Targeted neurorehabilitation strategies in post-stroke aphasia[J]. *Restor Neurol Neurosci*, 2023(3-4):129-191.

[7] 徐刚，闫国立. 医学统计方法学[M]. 北京：中国中医药出版社，2019:18-19.

[8] 中华医学会神经病学分会，中华医学会神经病学分会脑血管病学组. 中国各类主要脑血管病诊断要点2019[J]. 中华神经科杂志，2019(9):710-715.

[9] 李胜利，肖兰，田鸿，等. 汉语标准失语症检查法的编制与常模[J]. 中国康复理论与实践，2000(4):18-20,49.

[10] 高素荣. 论汉语失语检查法标准化[J]. 临床神经病学杂志，1992(4):193-195,250.

[11] 中风的诊断依据、证候分类、疗效评定：中华人民共和国中医药行业标准《中医内科病证诊断疗效标准》(ZY/T001.1-94)[J]. 辽宁中医药大学学报，2016(10):16.

[12] 中华中医药学会. 中医内科常见病诊疗指南中医病证部分：ZYYXH/T4-49—2008[S]. 北京：中国中医药出版社，2008:50-62.

[13] 吴勉华，王新月. 中医内科学[M]. 9 版. 北京：中国中医药出版社，2012:293-294.

[14] 饶明俐. 中国脑血管病防治指南[M]. 北京：人民卫生出版社，2007:41-71.

[15] FABIAN R, BUNKER L, HILLIS A E. Is aphasia treatment beneficial for the elderly? A review of recent evidence[J]. *Curr Phys Med Rehabil Rep*, 2020(4):478-492.

[16] KAZI S A, SIDDIQUI M, MAJID S. Stroke outcome prediction using admission NIHSS in anterior and posterior circulation stroke[J]. *J Ayub Med Coll Abbottabad*, 2021(2):274-278.

[17] 于增志，王军，周文生，等. 脑损伤后失语症与认知功能障碍：简易智力状况检查法评估[J]. 中国临床康复，2005(16):76-77.

[18] YAN Z, HE X, CHENG M, *et al*. Clinical study of melodic intonation therapy combined with transcranial direct current stimulation for post-stroke aphasia: a single-blind, randomized controlled trial[J]. *Front Neurosci*, 2023:1088218.

[19] 周冰原，朱才丰，王驰，等. 基于数据挖掘研究针-药结合治疗中风后失语症的临床规律[J]. 中医临床研究，2023(7):88-96.

[20] 陈改平，杨郁文，倪斐琳，等. 杵针疗法对中风运动性失语患者语言康复的研究[J]. 上海针灸杂志，2018(7):742-745.

[21] CHANG J, ZHANG H, TAN Z, *et al*. Effect of electro-acupuncture in patients with post-stroke motor aphasia:

中国知网 https://www.cnki.net

neurolinguistic and neuroimaging characteristics[J]. *Wien Klin Wochenschr*, 2017(3-4):102-109.

[22] 费爱华,徐斌.蔡圣朝运用针灸治疗中风后失语经验[J].安徽中医药大学学报,2015(5):45-47.

[23] 郭锋.基于数据挖掘技术研究蔡圣朝教授治疗中风后运动性失语的学术经验[D].合肥:安徽中医药大学,2020.

[24] 周冰原,朱才丰,魏鹏,等.基于知识图谱技术分析针灸治疗失语症转化研究的现状与趋势[J].针刺研究,2023(11):1175-1182.

[25] 李齐玉,金晓洋.脑肠同调针刺法治疗急性缺血性脑卒中的疗效及对血清 CGRP、5-HT、MTL 水平的影响[J].齐齐哈尔医学院学报,2025(5):470-474.

[26] 杨葵,张松鹤,陈科技,等.血清 NSE、ET、MMP-9 水平对高血压脑出血手术患者近期预后不良的预测分析[J].黑龙江医药科学,2025(4):159-163.

[27] 王高临,李斌,韩桂浩,等.血清 HIF-1α、NSE、Hcy 水平与急性缺血性脑卒中介入手术患者神经功能的关系[J].中国现代医学杂志,2025(5):78-83.

[28] 齐培培,张明秋,李敏.血塞通注射液辅助治疗急性脑梗死的效果观察[J].保健医学研究与实践,2023(3):24-26,34.

收稿日期 2025-08-11

《上海针灸杂志》“专题研究”栏目征稿启事

《上海针灸杂志》(CN 31-1317/R,月刊)由上海市卫生健康委员会主管,上海市针灸学会和上海市中医药研究院主办,上海市针灸经络研究所承办;是中国科技核心期刊、中国科学引文数据库(Chinese Science Citation Database, CSCD)来源期刊、中国生物医学核心期刊和中国学术期刊综合评价数据库(Chinese Academic Journal Comprehensive Evaluation Database, CAJCED)统计源期刊。

《上海针灸杂志》栏目设置多样,理论与实践并重,提高与普及兼顾,既能反映针灸学术发展的较高水平,又能满足一般基层医生的临床需要。目前新增“专题研究”栏目,旨在重点关注热点问题的最新研究成果和常见病的临床研究或独特经验。为进一步丰富“专题研究”栏目的内容,诚邀广大作者积极投稿,本刊将择优录用并优先发表。

专栏主题范围

针灸治疗中风、失眠、抑郁、痴呆、变应性鼻炎、哮喘、慢性胃炎、炎症性肠病、膝骨关节炎、腰椎间盘突出症和不孕以及针灸镇痛的相关临床研究、机制探讨及综述。

投稿途径

请通过《上海针灸杂志》在线投稿系统(www.acumoxj.com)进行投稿,投稿时备注“专题研究”。

稿件要求

投稿文章应未在正式出版物上发表过,不存在一稿多投现象,且必须保证文章的真实性和原创性。来稿须符合《上海针灸杂志投稿须知》中的要求。稿件类型无限制(包括但不限于临床研究、临床报道、文献研究和综述)。

《上海针灸杂志》编辑部

中国知网 https://www.cnki.net